

1. Introducción y relevancia clínica

La **dermatitis seborreica (DS)** es una **enfermedad inflamatoria crónica, recidivante**, que afecta las áreas de piel **ricas en glándulas sebáceas**, como cuero cabelludo, cara, orejas y parte superior del tronco.

Se caracteriza por **eritema y descamación amarillenta o blanquecina**, con **intensidad variable**, asociada a **prurito leve a moderado**.

Relevancia clínica

- Es una **patología muy frecuente**, afectando al **1–5% de la población adulta**, y hasta **70% de los lactantes** (forma infantil).
- Tiene impacto cosmético, social y psicológico significativo.
- En adultos, puede ser **marcador de inmunosupresión** (VIH, enfermedad neurológica, estrés, Parkinson).
- En lactantes, se presenta como **costra láctea**, de curso benigno y autolimitado.
- En EUNACOM, es una pregunta clásica de diagnóstico diferencial con **psoriasis, dermatitis atópica y tiña**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La fisiopatología de la DS es **multifactorial** e involucra cuatro elementos principales:

2.1. Hipersecreción sebácea

- Las glándulas sebáceas están hiperactivas en áreas afectadas.
- Sin embargo, no hay correlación directa entre cantidad de sebo y severidad.

2.2. Proliferación de *Malassezia* spp.

- Levadura lipofílica (antes *Pityrosporum ovale*) comensal de la piel.

- Su proliferación excesiva genera **metabolitos irritantes** de los lípidos sebáceos → inflamación.
- La respuesta inmune alterada frente a *Malassezia* es un factor central.

2.3. Respuesta inflamatoria individual

- Predisposición genética e inmunológica.
- Disfunción en la respuesta Th1/Th17 → inflamación cutánea persistente.

2.4. Factores desencadenantes

- Estrés emocional, fatiga, clima frío, humedad, alcohol, inmunosupresión (VIH, corticoterapia sistémica).
 - En lactantes: paso de hormonas maternas que estimulan glándulas sebáceas.
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones generales

- **Eritema con descamación fina o gruesa, blanquecina o amarillenta.**
 - **Prurito leve a moderado**, a veces sensación de ardor.
 - Curso **crónico, con exacerbaciones** en invierno y mejoría con el sol.
 - Afecta **áreas seborreicas**: cuero cabelludo, cara (cejas, surcos nasogenianos), conducto auditivo externo, tórax, región interescapular.
-

3.2. Formas clínicas

A. Dermatitis seborreica del adulto

- Localización más frecuente:
 - **Cuero cabelludo** (caspa): escamas finas, secas o grasosas.

- **Cara:** cejas, surcos nasogenianos, orejas.
- **Tórax superior:** placas eritematoescamosas en forma de “mariposa”.
- Prurito leve, empeora con estrés o falta de sueño.
- En casos graves (inmunodeprimidos): lesiones extensas, costrosas, generalizadas.

B. Dermatitis seborreica del lactante (costra láctea)

- Aparece entre la **2ª y 12ª semana de vida**.
- Placas amarillentas, grasosas, adherentes en el **cuero cabelludo**, a veces en cara o pliegues.
- **No pruriginosa**, curso benigno y autolimitado (resuelve en 3–4 meses).

C. Dermatitis seborreica en inmunodeprimidos

- En VIH o enfermedad de Parkinson.
- Lesiones más extensas, inflamatorias, costrosas y refractarias al tratamiento habitual.
- En VIH, puede ser el **primer signo cutáneo de inmunosupresión**.

3.3. Diagnóstico diferencial

Patología	Diferencias clave
Psoriasis	Escamas más gruesas y plateadas, placas bien delimitadas, menos grasosas
Dermatitis atópica	Inicio en infancia, prurito más intenso, piel seca generalizada
Tiña capitis / corporis	Bordes activos, alopecia, examen directo con KOH positivo

Rosácea	Eritema facial persistente con telangiectasias, sin descamación
Lupus eritematoso cutáneo	Placas eritematosas en áreas fotoexpuestas, anticuerpos positivos

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

- **Fundamentalmente clínico**, por localización y morfología típica de las lesiones.
- No se requieren exámenes rutinarios.

4.2. Exámenes complementarios (en casos atípicos)

Examen	Indicación	Resultado esperado
Examen directo con KOH	Si se sospecha tiña	Negativo
Biopsia cutánea	Casos dudosos (psoriasis vs seborreica)	Espongiosis, paraqueratosis focal, infiltrado perivascular
Prueba de VIH	En lesiones graves, costrosas o refractarias	Positiva en algunos casos
Hemograma / perfil metabólico	Si se sospecha inmunosupresión o enfermedad sistémica	Variable

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1. Objetivos

- Reducir inflamación y proliferación de *Malassezia*.
 - Controlar prurito y descamación.
 - Mantener remisión con medidas higiénicas y tópicas de mantenimiento.
-

5.2. Tratamiento general

1. Medidas higiénicas

- Lavar las zonas afectadas con **champú anticaspa o antifúngico** (2–3 veces/semana).
 - Evitar productos grasos o cosméticos oclusivos.
 - Reducir estrés, alcohol y tabaco.
 - Exposición solar moderada puede mejorar síntomas.
-

2. Tratamiento tópico (primera línea)

Área afectada	Tratamiento	Frecuencia / duración
Cuero cabelludo (forma leve)	Champú con ketoconazol 2%, ciclopirox o zinc piritiona	2–3 veces/semana × 4 semanas
Cara y pliegues	Ketoconazol 2% crema o gel	1–2 veces/día hasta remisión
Lesiones inflamatorias	Corticoide tópico de baja potencia (hidrocortisona 1%) o inhibidor de calcineurina (pimecrolimus/tacrolimus)	1–2 semanas, luego suspender

Lactante (costra láctea)	Emolientes (aceite mineral o vaselina) + eliminación suave con cepillo; si persiste, ketoconazol 1–2%	Aplicar cada 48 h × 1 semana
---------------------------------	---	------------------------------

3. Casos moderados o refractarios

- **Ciclopirox olamina 1% crema o shampoo.**
- **Ketoconazol oral 200 mg/día × 7–14 días** en casos resistentes o en inmunosupresión (bajo control médico).
- Alternativas: itraconazol o fluconazol.

4. Mantenimiento

- Usar champú antifúngico **1 vez/semana** para prevenir recaídas.
- Hidratación con cremas no comedogénicas.
- En recurrencias frecuentes, alternar antifúngico y antiinflamatorio tópico suave.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo / características	Manejo
Sobreinfección bacteriana (impétigo secundario)	Excoriación o rascado	Antibióticos tópicos (mupirocina)
Dermatitis seborreica severa en VIH	Inmunosupresión subyacente	Evaluar y tratar VIH
Eritrodermia seborreica	Forma grave, extensa	Derivar a dermatología

Recaídas frecuentes

Estrés, suspensión de
tratamiento

Mantenimiento antifúngica
intermitente

Pronóstico:

- En **lactantes**, autolimitada (resuelve en meses).
 - En **adultos**, curso crónico recidivante, controlable con terapia tópica continua.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. La **localización típica** (cuero cabelludo, cejas, surcos nasogenianos, tórax superior) orienta el diagnóstico.
 2. En **lactantes**, la DS se presenta como **costra láctea**, sin prurito ni compromiso general.
 3. **Ketoconazol tópico** es el tratamiento de elección en todas las edades.
 4. **Corticoides tópicos de baja potencia** pueden usarse brevemente en brotes inflamatorios.
 5. En casos severos o refractarios, **descartar VIH o Parkinson**.
 6. La **mejoría con el sol** es característica y orienta diagnóstico.
 7. En EUNACOM, el caso clásico es **paciente adulto con eritema y escamas amarillas en surcos nasogenianos y cuero cabelludo**.
-



Errores comunes

- Usar corticoides potentes prolongadamente → atrofia y rebote.

- Diagnosticar erróneamente psoriasis o tiña (bordes bien definidos o KOH positivo).
 - No tratar la colonización por *Malassezia* con antifúngicos.
 - Suspender el tratamiento al desaparecer los síntomas → recidiva precoz.
 - Ignorar causas subyacentes (estrés, VIH).
 - Aplicar champú medicado sobre cuero cabelludo seco → irritación.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **dermatitis seborreica** es una enfermedad inflamatoria crónica de las áreas seborreicas, causada por **respuesta anómala a Malassezia**.
2. Se manifiesta como **eritema con escamas amarillentas o blanquecinas**, en cuero cabelludo, cara o tórax.
3. En **lactantes**, se presenta como **costra láctea**, benigna y autolimitada.
4. El diagnóstico es **clínico**, sin necesidad de exámenes complementarios.
5. El **tratamiento de elección** es **ketoconazol tópico 2%** (champú o crema).
6. Los **corticoides tópicos suaves** se usan solo en brotes inflamatorios cortos.
7. En casos extensos o refractarios, **descartar inmunosupresión (VIH, Parkinson)**.